

안이비 11주차

강조한 질환 위주로 보기

비과학각론 목차

I. 外鼻疾患

1. 기형 및 변형
2. 외상
3. 외비종양
4. 비전정피부염
5. 주사비

II. 鼻中隔疾患

1. 건성전비염
2. 비중격농양
3. 비중격궤양
4. 비중격천공
5. 비중격종양
6. 비중격기형

III. 鼻腔疾患

1. 비절
2. 鼻疔
3. 비내용종
4. 비강이물
5. 비출혈
6. 알레르기 비염
7. 급성비염
8. 만성비염

IV. 副鼻洞疾患

1. 부비동염
2. 副鼻洞 腫瘍

V. 證候性鼻疾患

1. 鼻痛
2. 鼻焦乾
3. 鼻內癢痒
4. 鼻痠
5. 鼻砧痧
6. 鼻出臭氣
7. 鼻冷
8. 鼻如烟煤
9. 肺風粉刺
10. 鼻梅毒
11. 嗅覺障礙

01 외비질환

기형 및 변형

가. 선천성 기형 및 변형

- 원인불명. 산모 임신 초기 질환, 약물 등
- 기형: 猿頭症, 무비증, 다비증, 코끝기형, 정중 및 외측 비열
- 변형: 曲鼻, 廣鼻, 長鼻, 鞍鼻, 偏側脣裂鼻. 합병증(토순, 구개파열 등)

나. 후천성 기형 및 변형

- 외상 또는 매독, 결핵, 나병, 디프테리아 등
- 鞍鼻(비골골절, 비중격 수술, 매독, 결핵), 斜鼻(골성, 연골성 비배 외상), 전비공 폐색증(외상, 화상, 부식, 매독, 디프테리아)

→ 외비질환 중 기형과 변형은 한방에서 접근하기 쉽지 않음

외상

- 韓: 鼻傷腫痛, 皮肉破損, 鼻傷出血, 鼻梁骨折

- 1) 원인: 폭력이나 사고, 특히 교통사고로 인한 비골 골절, 좌상이 주. 이외 切創, 刺創, 咬傷, 軟骨脫臼
- 2) 증상: 鼻衄, 瘀腫疼痛, 皮下 반상 출혈, 골절단의 염발음, 비폐색, 鼻梁骨의 골절로 왜곡, 함몰
- 3) 치료: 桃紅四物湯, 當歸鬚散. 鼻衄(烏賊骨, 三七根, 梔子炭末로 塞鼻). 양방(지혈 및 10일 내 비정복술 시행)
- 4) 외치법: 24시간 이내에는 냉찜질, 이후 온찜질. 當歸膏, 消毒定痛散, 補肉膏 등 敷貼

외비종양

- 韓: 鼻疽

- 鼻腫보다 극심한 증상

- 원인: 風熱 或 熱毒, 疳熱, 脾胃濕熱

- 증상: 초기 鼻柱 或 鼻梁骨 腫大, 發熱疼痛. 진행되면서 紫色, 腫脹, 堅硬鈍痛. 심하면 潰瘍, 미란, 황수유출, 비익, 구순까지 파급, 외비 변형 발생

- 치료

- 1) 음주나 積熱시 銀花甘草湯
- 2) 진행시 五味消毒飲, 黃連解毒湯, 仙方活命飲

3) 악화되면 安宮牛黃丸, 犀黃醒消丸

- 분류

1) 양성 종양: 혈관종, 낭포, 색소성 모반, 섬유종 등

2) 악성 종양: 기저세포암, 편평상피암

- 비익에서 원발하는 경우가 많고, 특히 편평상피암은 비강, 부비동에서 시작되어 外鼻로 나타나는 형태임

→ 피부에 흑색종이 보이면 전신검사가 필요할 수도 있고, 흑색종은 악성 종양 중에서 골치 아픈 케이스

비전정 피부염

비전정 : 콧구멍 안쪽. 콧털이 나는 부분

- 痂皮 형성, 상피 결손특징

- 원인: 급만성 비염, 부비동염, 소아 아데노이드 증식증 등에 의한 비분비물의 증가, 당뇨

- 증상: 外鼻孔의 심한 소양감, 발적, 종창, 가피. 진행되면 鼻翼, 上口唇에 파급되어 작열감, 소양감, 비폐색이 발생. 만성화되면 피부 비후, 발적, 균열, 가피

- 韓: 鼻疳, 鼻狼瘡, 鼻蠱瘡

- 소아에서 다발, 慢性 鼻炎에서 흔히 동반. 재발

- 원인: 風濕熱邪가 코에 침입, 코 분비물의 자극. 소아(疳熱), 성인(肺經蘊熱, 濕熱)

- 증상: 鼻竅의 하부 양방 기육에 濕爛, 糜爛, 경미한 동통, 소양, 皸裂, 膿痂와 黃水 유출이 반복 발생. 소아는 瘡이 구순까지 파급, 多啼

- 농성 분비물을 동반하는 비연, 비구 등을 제거하는 것이 중요. 손가락으로 콧구멍을 후비지 않도록 함

- 치료

1) 肺經蘊熱: 초기 前鼻孔 皮膚 灼熱, 微痒, 微痛, 上脣까지 皮膚 潮紅腫脹 - 萬金湯, 銀翹散, 瀉白散

2) 濕熱: 항상 脂水가 流出 - 除濕湯, 草薢滲濕湯

3) 陰虛血燥: 病程이 길고, 반복해서 재발 - 四物消風飲

4) 소아 疳熱: 五福化毒丹

5) 外治: 清洗, 敷藥 - 黃連膏, 靑黛散

6) 침구치료: 合谷, 外關, 少商, 曲池

주사비

- 50대이상 성인 남자 호발

- 주사비(rosacea), 주사좌창(acne rosacea), 비류(rhinophyma)의 증상

- 원인: 불분명. 유전설, 혈관 장애, 과도한 음주, 커피나 차의 남용, 만성적인 위장질환, 熱과 冷에 장기간 노출로 인한 반복적인 외부 자극, 감염 등

- 치료: 원인 인자 제거. 호르몬 요법, 레이저 수술, 성형수술

- 韓: 鼻赤, 肺風瘡, 鼻齧, 酒齧, 赤齧 → ★이거 보고 주사비라는데 알아야함★

- 원인: 酒氣薰蒸, 血熱入肺, 血瘀凝結

- 증상

1) 紅斑期(1기) : 미만성 홍반, 피지선의 유성광택인 脂漏 증가, 진피 모세혈관 확충 등이 鼻尖部에 발생

2) 痤瘡期(2기) : 얼굴에 좌창양 피진, 농포 다발

3) 鼻瘤期(3기) : 말기상태. 비첨부에 결합조직 증식, 피지선 비대로 요철의 기형이 발생. 촉진상 말랑말랑한 불규칙한 혹이 있어 압박하면 악취가 나는 분비물이 나옴

- 치료

1) 脾胃積熱: 三黃梔子湯

2) 肺經蘊熱: 黃芩清肺飲

3) 血瘀阻滯: 涼血四物湯

4) 肺風瘡 : 升麻防風散, 清肺飲子

5) 酒熱: 酒製通聖散

6) 外治: 硫黃膏, 顛倒散, 蛤粉膏

7) 침구치료

- 體針(관료, 영향, 인당, 승장, 지창, 소료 取穴, 곡지, 상성, 합곡, 대영, 화료혈 배합)

- 耳針(屏間, 腦, 肺, 胃, 神門, 外鼻)

- 打刺(梅花針)

- 혈위주사(迎香. 당귀, 단삼, 어성초, 비타민 B1 주사액)

→ 상열감을 유발할 수 있고, 칼로리가 높은 음식을 주의해야함

02 비중격질환

비중격이 휘 것 때문에 좁은 쪽이 더 잘 막히고 호흡이 불편

- 양방에서 골성 및 연골성 중격의 만곡으로 비강의 호흡 기능에 장애가 나타나 흡수와 배설이 안되 만성적인 비질환으로 나타나기 때문에 중요
- 최근에는 직업병 양상으로 비중격의 궤양 및 천공 형태가 다발(鼻癰, 馬鼻疽, 楊梅瘡에 해당)
- 치료: 외과 응저 치료

건성 전비염

★ 건성 전비염과 위축성 비염을 감별하시오. (15)

★ 37세 남자. 화학공장에서 일하는데 1달 전부터 ~ 서양의학적 병명은? (11,14,17,19)

- 비중격 전단 상피 결손으로 가피 형성. 위축성 비염 초기와 유사
- 얇고 건조한 가피가 비중격 앞쪽에 생기는데 특징적
- 韓: 鼻疳, 鼻蠟瘡
- 원인: 자극성 물질 흡입, 뜨겁고 건조, 먼지가 많은 곳에서 호발
- 증상: 비강 건조, 소양, 긴장감 심해 굵어 미란, 출혈 및 황갈색 반점, 痂皮, 점차 궤양, 천공 형성, 제거시 출혈 동반
- 감별: **얇고 건조한 가피가 비강 전방부에만** 있고 비인강이나 인두까지 이르지 않으며, **악취가 나지 않는 점이 위축성 비염과 차이점** → ★이 부분 강조하심★
- 변증론치
 - 1) 肺經蘊熱: 黃芩湯, 銀翹散, 瀉白散
 - 2) 脾胃失調 濕熱蘊積: 草薢滲濕湯
 - 3) 外用: 靑蛤散
- 치료: 손가락으로 소파 금지. 가피 제거 주의. 궤양은 초산은 소작, 연고

비중격 농양

- 韓: 鼻內癰
- 원인: 비중격 혈종의 화농, 근접부위의 감염, 급성 열성질환, 만성 전염병, 중금속 중독
- 증상: 수상 후 수일 내지 10일 이내에 비중격 점막하에 농포, 농양 형성, 발열, 오한, 비 폐색, 전두통, 鼻背의 동통 및 압통, 비루, 심하면 연골 괴사
- 변증론치
 - 1) 仙方活命飲, 千金漏蘆湯

2) 腫大疼痛, 화농되려 할 때: 托裏透膿湯

3) 潰瘍시: 癰疽潰瘍部 참조

- 치료: 항생제 투여, 외과적 절개 배농. 괴사시 응비술 또는 확대비성형
- 드물게 해면상 정맥동 혈전증, 뇌막염, 패혈증 등의 합병증 및 비중격연골의 괴사로 안 비 발생

비중격 궤양

- 원인: 주로 직업(화학약품 흡입). 매독, 낭창, 나병, 결핵 등과 만성적인 전신성 질환
- 증상: 가피, 반복적 비출혈, 건조, 소양감. 골 괴사시 특유의 악취 동반
- 변증론치
 - 1) 五味消毒飲, 消風敗毒散, 托裏消毒飲 등
 - 2) 궤양이 오래되거나 正氣부족: 十全大補湯, 補中益氣湯
- 치료: 가피를 제거하지 말고 자주 따뜻한 생리식염수로 세척, 바세린 연고 도포

비중격 천공

- 원인: 외상, 비중격 교정 후, 매독, 결핵, 나병 등의 급성 전염병, 비중격의 궤양성 질환
- 증상: 가피, 비폐색, 가피 제거 후 비출혈, 奇聲(whistling sound)
- 공기가 새면서 기이한 바람소리가 들린다는 뜻
- 치료: 원인질환이나 유발요인의 제거가 중요. 유성약제나 연고 도포, 비세척, 성형수술

비중격 종양

- 양성 종양 : 출혈성 鼻茸, 점액성 鼻茸
- 악성 종양 : 흑색육종, 흑색암종, 내피세포종 등
- 흑색종은 전이가 잘 되기 때문에, 전신을 다 스캔해봐야할 정도로 예후가 불량함
- 변증론치
 - 1) 염증시 : 防風通聖散, 普濟消毒飲
 - 2) 암종 : 수술로 제거

비중격 혈종

- 원인: 외상(골절, 비중격 교정 수술 후), 혈액질환(비중격 연골막사이 출혈)
- 증상: 비폐색, 전두통, 鼻背部에 압박감, 혈성 비루, 비중격 양측 혹은 편측의 평활한 종창
- 치료: 주사기로 혈액을 흡인, 외과적 배액술

비중격 기형

- 기형의 형태는 만곡(deviatio)이 가장 흔하고 능(ridge), 극(spine)이 있음
→ 한쪽으로 기울어져 있는 형태가 가장 많음
- 비중격만곡은 좌측 만곡이 80% 정도로 다발
- 원인: 선천성 또는 발육이상, 외상(분만시 외상, 직업), 압박(비갑개의 비후, 종양, 비용)
- 분류: 경도(중비도가 잘 보임), 중등도(중비갑개가 약간 보임), 고도(중비도, 중비갑개 모두 안보임)
- 증상: 비폐색, 구호흡, 후비루/ 두중감, 수면장애, 기억력감퇴, 비성 주의산만증, 鼻聲, 후각장애
- 치료: 수술(비중격 발육이 완성되는 만 17세이후)

비중격 신경증

- 鼻痛, 鼻痠과 유사. 비성 신경증, 신경통의 일종
- 원인: 정신신경성 장애, 삼차신경 제1지나 제2지의 신경통, 대상포진 휴유증
- 증상: 비중격의 저린감, 壓痛 / 眼痛, 耳나 頸部로의 방산통, 비전정의 발적, 鼻漏 過多, 해수, 천식, 재채기, 딸꾹질 혹은 胃痛, 소화기 장애, 변비, 심계항진, 홍민 병발
- 치료: 원인 제거. 보존적 치료

03 비강질환

비절

- 韓: 鼻瘡
- 원인: 감기나 코털 뽑기, 코를 자주 풀거나 후벼서 포도상구균, 연쇄상구균의 감염
- 증상: 비전정에 격렬한 동통, 발적, 압통, 농포 등 발생. 전신증상(발열, 오한, 두통, 권태 등) 동반. 비강질환, 당뇨병이 있는 사람에서 다발
- 치료: 국소 청결, 코털 제거 등 고식적인 방법 시행. 농점 절개 배농
- 원인: 肺經壅熱, 胃熱, 時氣邪毒
- 증상: 초기에 비강내에 微痒 微痛, 발열, 홍종, 粟粒狀 구진 발생. 점차 작열, 동통, 건조가 심해지면서 궤양, 미란, 가피 형성
- 치료
 - 1) 內治: 生地黃四物湯, 黃芩湯, 洗肺散, 黃連解毒湯, 四白散
 - 2) 外治: 黃連膏, 辰砂定痛散 搽鼻
- 서양의학: 비전정의 모낭에서 발생하는 괴사성, 화농성 질환인 비전정절

鼻疔 비정

- 이명: 白丁, 白刃疔, 鼻尖疔
- 원인: 風熱邪毒, 肺胃積熱, 邪毒內陷入營
- 증상: 초기 鼻瘡과 유사. 점차 비공이 脹塞되어 호흡 불능, 극렬한 동통, 심하면 唇腮部 모두 종대.
- 疔瘡走黃(根脚緊硬, 釘狀, 瘡頂黃色膿點, 頂高根軟, 紫暗色), 邪毒入營血 心包內陷(증한발열, 번조불안, 오심구토, 정신혼미, 경련, 사지한냉, 舌紅絳, 苔厚黃稠, 脈洪數)으로 생명위험
- 치료
 - 1) 邪毒 外襲, 火毒 上攻: 仙方活命飲, 五味消毒飲, 黃連解毒湯
 - 2) 심하면: 犀角地黃湯合黃連解毒湯
 - 3) 心包內陷: 安宮牛黃丸, 紫雪丹
 - 4) 外治: 환처 수차례 排膿, 玉露膏, 金黃散, 紫金錠
- 서양의학 : 비전정 염증 또는 비절의 심한 증상, 안면의 위험삼각부의 鼻性 봉와직염, 단독 또는 비강내 종양

비강내 종양

1) 양성 종양

- 유두종: 비전정 피부점막 이행부, 우상
- 혈관종: 출혈성 비출
- 골종: 부비동(전두동) 양성종양.
- 선종: 비중격, 중 하비갑개, 부비동 등

2) 악성종양

- 비강암: 50대 이후 남성. 비갑개, 비중격, 비전정, 후비공, 비강저 순
- 상악암: 편평상피암. 흡연 성인이 수 주 동안 **일측성** 농성, 혈성비루 지속시 의심. 예 후 불량 → 편측성, 양측성 양상에 따라 특징적인 질환들 잘 알아두기
- 악성 흑색종 및 연골육종

비내용종

- 비강내에서 보이는 灰黃色, 灰赤色の 유리광택 나는 유연한 신생물 → 폴립이라고 부름
- 20~30세 성인 남자 호발
- 원인: 비강이나 부비동의 만성적 염증시 발생. 알레르기
- 부위: 주로 중비도, 특히 사골동 및 상악동의 개구부, 비강 측벽에서 다발
- 증상: 심한 비폐색, 후각장애, 유루, 비루, 두통, 폐쇄성 鼻聲, 심하면 미간 동통 및 외비 변형초래
- 치료: 수술요법(재발 잘됨). 1% ephedrine 점비
- 韓: 鼻痔, 鼻瘖肉, 鼻茸
- 원인: 肺氣虛寒, 肺經熱盛, 風濕熱鬱, 脾胃濕熱
- 증상: 초기에 표면이 평활, 유연한 석류상의, 담홍색, 회백색 혹 암홍색 瘖肉이 점차 커져 비규 외로 下垂. 鼻塞 甚, 두통, 두중감, 후각감소, 때로 鼻痛, 濁涕
- 치료 → ★창이자산을 합방해서 쓰는거 매우 강조하심★
 - 1) 脾氣虛弱: 蒼耳子散 合 補中益氣湯, 溫肺止流丹
 - 2) 脾濕犯肺: 蒼耳子散 合 二陳湯
 - 3) 肺經鬱熱: 蒼耳子散 合 桃紅四物湯, 辛夷清肺飲, 瀉白散, 防風通聖散, 荊芥連翹湯
 - 4) 食積熱痰, 脾胃濕熱: 星夏湯, 鬱金散
 - 5) 外治 : 瓜丁散, 瓜簞散, 辛夷膏 塗敷

비강이물

- 이물질이 비강내에 들어가 비폐색, 악취, 두통 등 유발
- 원인 : 소아(장난으로 이물을 코에 삽입), 성인(코치료중 거즈가 남았거나 음식물 삼키다가 재채기하여 역류, 곤충 잔류 등)
- 증상 : 처음에 재채기, 눈물이 나고 2~3일후부터 일측성 비색감, 콧물이 많고 악취가 있는 농성 혹은 혈성 분비물이 있음.
- 소아에서 편측으로 악취와 함께 농성 분비물이 나오면 이물 의심. 오래되면 주변조직에 육아종 발생
- 치료
 - 1) 작은 이물: 通管散으로 재채기 유발한 후 제거
 - 2) 작고 매끈한 이물: 윤활유 바른 후에 건측 비강을 지압하여 배출
 - 3) 형태가 일정하지 않은 이물: 겸자나 특수한 기구를 이용해 배출
 - 4) 비강으로 배출이 어려운 경우: 환자 양와위 상태에서 두위를 아래로 한 후 비인두로 배출

(비출혈부터는 잘 알아두라고 강조하심)

비출혈

★ Case 문제 처방, 변증 (08,11,12,13,14,17,18)

- 韓: 鼻衄, 衄血, 鼻洪, 腦衄, 紅汗, 倒經
- 원인: 80~90% 원인불명
- 1) 국소적: 기계적 외상(타박상, 골절, 코 후빔) / 염증(급성 상기도 감염, 비전정염, 부비동염, 알레르기) / 종양과 동맥류(혈관 섬유종, 흑색종, 편평세포암종, 내경동맥의 동맥류) / 염산, 유독가스, 먼지, 이물 등
- 2) 전신적: 나이(동맥벽 섬유화) / 고혈압 / 혈액응고장애(혈우병, AIDS, 간질환 등 혈소판 감소증 및 혈소판 질환을 유발하는 내과질환) / 약물(헤파린, 아스피린, NSAID) / 급성 전염병(장티푸스, 홍역, 성홍열 등) / Vit C 및 K 결핍증, 대상성 출혈
- 3) 기후적: 날씨가 건조하고 추울수록 증가, 겨울철에 입원환자가 증가
- 출혈양상: 자발성, 속발성, 대상성
- 부위: 비골 골절, 일부 혈액질환을 제외하고 대부분 일측성
 - 1) 외상: **kiesselbach's plexus** (비중격분지의 풍부한 문합, 점막하 조직이 적고 혈관이 연골과 점막사이로 쉽게 외상). 젊은 층에 호발
 - 2) 고혈압: 비강 후부, 하비도의 후단부. 고연령층에 다발
 - 3) 종양: 중비도. 이외 비강저, 부비동

- 원인, 증상 및 치료 → ★비출혈 변증시치는 꼭 알아두기★

1) 心火亢盛: 반복적 量多 혹은 量少 + 口舌生瘡 - 瀉心湯加味, 三黃補血湯

2) 肺經熱盛: 風熱表證 + 出血量小, 鮮紅 - 蔞蘇飲, 養陰清肺湯

3) 胃熱熾盛: 돌연히 量多, 鮮紅色 + 口渴喜冷飲 - 清胃湯加減

4) 肝火上逆: 돌연히 量多, 鮮紅色, 반복발생 + 面紅目赤, 口苦咽乾-龍膽瀉肝湯, 犀角地黃湯

5) 肝腎陰虛: 紅色, 반복적, 量多 + 心悸, 眼花, 耳鳴, 盜汗 - 知柏地黃湯

6) 脾不統血: 淡紅色, 滲滲히 量多 혹은 量少 + 食慾不振, 氣短, 神疲懶言 - 補中益氣湯加減, 益氣養血湯

→ 2,3,4번은 실증에서 자주 나타나는 변증 / 5,6번(특히 6)은 허증에서 자주 나타나는 변증

→ 실증은 선홍색 / 허증은 담홍색

→ 돌연히 코피가 나며 양이 많으면 위열, 간화 / 자다가 코피가 나며 양이 적으면 폐열

- 치료: 환자를 앉히고 안정시키며 혈액은 삼키지 않도록 주의. 가벼운 경우 두 손가락으로 양 비익을 비중격을 향해 압박(약 5~10분간). 심하면 전비공 또는 후비공 팩킹. Adrenalin / 전기소작, Vit K, 항생제(2차감염 예방)

- 예방을 위해 용천혈 뜸치료

알레르기 비염

★ 알레르기성 비염과 혈관운동성 비염의 비강소견을 비교하시오. (11,17)

★ 알레르기성 비염, 혈관운동성 비염, 만성단순성 비염, 만성비후성 비염의 비경 소견을 각각 감별하시오. (19)

★ 서양의학의 급성비염, 만성비염, 알레르기성 비염에 해당하는 한의학적 병명은? (08,09,13)

★알레르기 비염과 혈관운동성 비염을 반드시 구분해야함★

→ 상병명 대분류가 같이 묶여있는데, 첩약 건강보험에서는 혈관운동성 비염은 인정이 안되고 알레르기 비염만 되기 때문에 이 둘을 감별하는게 매우 중요

- 韓: 鼻噴, 噴嚏, 嚏噴, 發嚏

- 항원에 의해 과민한 비강에 반복 발생하는 만성 비염의 일종

- 환자의 30%에서 유전적 요인 작용

- 항원: 흡입성 항원(집먼지, 꽃가루, 곰팡이 등), 식이성 항원(육류, 계란, 어패류 등)

- 원인

1) 계절성: 급성적, 봄, 가을에 호발, 화분증, 고초열

2) 통년성: 만성적, 연중 계속(9개월이상/년), 동물의 털, 비듬, 직물류, 식품 등

- 증상: ★재채기 발작, 수양 비루, 비폐색 / 비내소양감★, 수명, 유루, 전두통

→ ★알레르기 비염 3대증상 + 비내소양감 = 4대증상 꼭 알아두기★

- 비경상 하비갑개 점막의 광택을 띤 담홍색 혹은 창백, 회홍색의 종창이 있음

- 검사 : MAST Allergy 검사(Food 62종, Inhalant 62종)

- 원인: 肺氣虛弱, 脾胃濕熱, 腎氣不足

- 증상: 돌연 비규내 소양감과 함께 비색, 비류청체, 분체 등이 발생. 오랫동안 반복 발생.

- 치료: 外感風寒, 風熱(蔞蘇飲, 加味通竅湯, 辛夷清肺飲, 麗澤通氣湯), 脾肺氣虛(當歸四逆加吳茱萸生薑湯, 溫肺止流丹), 脾胃濕熱(葛根解肌湯, 荊芥連翹湯), 腎氣不足(六味地黃湯) / 소아 肺氣虛弱(補中益氣湯合小青龍湯, 加味通竅湯)

- 치료: 회피요법, 약물요법(치료제, 면역요법, 탈감작요법), 수술(하비갑개 절제술)

알레르기반응 4+1가지

1. I 형: : anaphylaxis type, IgE dependent type. 천식, 알레르기 비염, 담마진, 약물 쇼크 등

2. II형: 세포용해성(cytolytic) , 세포독성(cytotoxic) , 조직특이성형(tissue specific type). 용혈성 빈혈, 혈소판감소성 자반병 등

3. III형: Arthus type, 면역복합체형(immune complex type). 혈청병, RA, 쇼그렌 증후군, SLE, 사구체 신염 등

→ I 형, II형, III형은 체액성 항체에 의한 것. 항원 노출 후 30분 이내에 반응 시작, 1~2 시간 후 소실되는 즉시형 알레르기 반응

4. IV형: 지연형(delayed type), 세포성(cell mediated), tuberculin형

→ 세포성 항체로 T임파구를 중심으로 일어나는 반응. 8~48시간 지나 반응시작, 수일~수주에 걸쳐 지속되는 지연형 알레르기 반응. 결핵, 접촉성 피부염 등

5. V형(최근): 자극형(stimulatory type) 항원항체반응으로 세포 자극 및 분열을 촉진

알레르기 비염의 특징소견

1. Allergic Salute : 코가 가려워 손바닥으로 코를 밀어 올리는 행동.

2. Transverse nasal crease : 콧잔등의 가로 주름. → 코를 계속 밀어 올리니까 생김

3. Allergic Shiner : 눈 밑의 울혈로 나타나는 보랏빛 착색.

4. Dennie's lines(Dennie-Morgan fold) : 눈 밑에 종창으로 생기는 깊은 주름.

알레르기 비염의 섭생법

- 아침 일찍 일어나 공복에 냉수를 마시는 습관을 버린다. 폐비허한이 되기 쉽다.

- 항상 아랫배를 따뜻하게 하는 습관을 기른다.
 - 평소 적당한 유산소 운동을 하여 심폐기능을 강하게 만든다.
 - 돼지고기, 닭고기, 밀가루 음식, 냉한 음식, 비린내 나는 생선 등의 음식은 주의한다.
- 돼지고기, 닭고기, 밀가루 음식 이런거 한약 복용할 때도 못먹게 함

혈관운동성 비염

- 심리적 인자와 정서적 요인, 피로 등과 밀접한 관계
 - 사무직중에 근무하는 청장년기층에 다발
 - 증상: **비폐색 또는 과도한 수양성 비루** / 재채기, 후비루, 안면신경통, 두통, 심한 피로감
- 알레르기 비염은 콧속이 간지러우면서 재채기가 심함
- ★혈관운동성 비염은 재채기, 콧속이 간지러운게 좀 덜함. 비폐색과 과도한 수양성 비루가 주 증상. 이걸로 구분하기★
- **비강소견: 하비갑개가 충혈되어 핑크색, 또는 매우 짙은 적색을 띠**
 - 진단: 비특이적 과민반응으로 특이 항원이 발견되지 않음
 - 치료: 국소 스테로이드제, 항콜린제

급성비염

- 韓: 鼻軌, 軌水, 鼻流涕, 軌涕, 軌嚏, 鼻鳴, 傷寒
- 상기도의 급성 감염. 봄, 가을에 주로 발생
- 원인: rhinovirus 감염
- 증상:
 - 1) 전구기(비점막 국소 빈혈기) : 오한, 발열, 두통, 전신위화감, 재채기, 인후열감 + 비점막 발적, 건조, 소양감, 작열감 있으나 종창은 없음
 - 2) 발적기(카타르기) : 비점막 발적, 종창, 폐색 심, 수양성 비루, 양안간 압박감
 - 3) 이차 감염기(점액기) : 2차적인 감염기. 점액성 혹은 농성 비루 + 인두염, 중이염, 부비동염, 이관염, 폐렴 등 합병증 발생
 - 4) 해소기(흡수기) : 대략 5~10일 정도 지나 발생

- 鼻痒, 鼻流涕, 噴嚏, 鼻塞 등이 돌발 또는 반복 발생하는 포괄적 症候
- 원인: 肺氣虛弱, 脾氣虛弱, 腎氣虛 + 風寒, 風熱 침범
- 증상: 초기 감모로 시작. 비내소양감, 비색, 비건조감, 噴嚏, 鼻流涕 + 발열, 오한, 오풍, 두통, 구갈구건, 인건, 咳嗽痰多, 肢節痺痛, 변비, 舌質紅, 苔薄白, 脈虛弱 혹은 濡弱

- 변증론치
 - 1) 통치방: 蔘蘇飲, 通竅湯, 桂枝湯, 葛根湯
 - 2) 外感風寒: 蔥豉湯
 - 3) 風寒의 重症: 荊防敗毒散, 麻黃湯
 - 4) 外感風熱: 銀翹散, 麗澤通氣湯
- 치료: 대증요법. 적절한 온도와 습도 유지, 충분한 수분섭취, 휴식

알레르기 비염과 급성 비염(코감기) 비교

→ ★증상 차이점을 감별해야함★

	알레르기 비염	급성 비염
원인	꽃가루, 집 먼지 진드기, 동물의 털 등	바이러스
증상	코가 간질간질하면서 갑자기 발생하는 재채기와 맑은 콧물, 코막힘, 열이 나는 느낌 (실제 발열은 없음)	콧물, 코막힘, 목이 아픔, 기침, 가래, 몸살, 두통, 발열 동반
치료	약물 치료(증상 치료제, 염증 치료제, 예방약), 원인물질 회피	약물치료(증상 치료제)
경과	1~2개월 이상 증상 지속	대부분 1주 이내 증상 호전

만성비염

- ★ 만성 단순성 비염과 만성 비후성 비염을 감별하시오. (18)
- ★ 만성 단순성 비염과 만성 비후성 비염의 비강소견을 감별하시오. (15)
- ★ Case 문제 (10,11,12,13,14,17)

가. 만성 비후성 비염

- 韓: 鼻艱, 鼻塞不利, 鼻塞, 鼻塞, 鼻壅塞
- 원인: 外感風寒, 風熱, 肺經鬱熱, 胃熱積盛, 肝膽濕熱, 脾氣虛弱, 肺腎陰虛, 氣滯血瘀
- 증상: 鼻竅 窒塞, 聲重, 鼻流涕, 噴嚏 등. 오래되면 不聞香臭
- 변증론치 → 어혈로 접근하기
 - 1) 肺經熱盛: 교대성 비폐색, 비체,鼻腔灼熱, 腫脹 및 充血이 특징적 + 口乾 = 辛夷清肺飲
 - 2) 肺脾氣虛: 백색 점도있는 鼻涕, 寒冷한 경우 鼻塞 증가, 비강내 담홍색 유연한 腫脹 + 咳嗽, 묽은 喀痰, 倦怠 등 = 溫肺止流丹

3) 脾氣虛弱: 蓼芩 白朮散

4) 邪毒久留: 지속적 鼻塞, 점도 높고 많은 鼻涕, 후각장애, 비강 腫脹은 색깔이 어둡고 딱딱한 편 + 인후두 이물감 = 當歸芍藥湯

5) 外治: 瓜蒂 散, 石菖蒲, 皂角 분말

1) 만성 단순성 비염

- 주로 비점막 혈관의 충혈, 염증으로 혈관 및 해면체조직 확장

- 원인: 급성 비염, 부비동염, 소아 편도비대와 염증, 만성 부비동염

- 증상: 머리위치 변경에 따라 좌우 비강에 교대로 일어나고 낮보다 밤에 심한 비폐색이 특징, 운동후에 비색감이 일시적으로 감소. 폐쇄성 비음, 점액성 후비루, 호흡성 후각장애 동반 → 비폐색 위주의 증상

- 비경상 비점막은 보통 창백, 율혈시 충혈, 홍자색. 표면 평활하고 균등하게 비후됨

- 혈관수축제에 쉽게 수축됨

- 치료: 세척(약알칼리성), 에페드린

2) 만성 비후성 비염

- 비점막의 암홍색 발적, 증식과 비갑개골의 비후로 거대한 하비갑개

- 원인: 만성 단순성 비염의 반복

- 증상: 심한 완고한 비폐색, 폐쇄성 비음, 후비루, 불문향취, 비루의 분비과다, 수면장애, 천식, 비성주위집중불능증 등

- 비경상 비점막은 암홍색. 표면이 울퉁불퉁. 하비갑개 전장이 비대되어 있고 촉진시 단단함

- 혈관수축제에 잘 반응하지 않음

- 치료: 비후가 심하면 초산은 부식, 절제

cf) 약물성 비염

- 국소적 비충혈제거제의 장기간 사용에 의한 만성 비염

- 비점막 혈관을 심하게 수축시켜 허혈성 점막손상 유발

- 혈관수축제 효과가 감소하면 비점막 발적, 종창 및 점차적 코막힘 발생

나. 만성 위축성 비염

- 韓: 鼻萎, 鼻臭, 鼻乾燥, 鼻出臭氣, 臭鼻症, 鼻槁腊

- 비강 속에 궤양 없이 惡臭, 萎縮, 痂皮를 형성하는 것 → 3대 증상

- 점막 및 하비갑개 골조조직의 위축으로 비강 기도는 넓으나 비폐색을 호소

- 원인: 젊은 여성에 호발, 겨울에 다발. 사춘기 전후에 시작되어 폐경기에 호전되는 경향. 원인불명, 갑상선과 난소와 관련, 비강 및 부비동질환, 수술후

- 증상: 악취, 녹색의 가피 형성, 하비갑개 점막 및 골조조직의 위축 / 비폐색, 후각장애, 비인두 건조감, 이물감, 목쉰소리 등

<臭鼻>

- 원인: 外感風熱이나 燥邪, 肺經燥熱, 肝膽濕熱, 脾胃濕熱

- 증상: 비규 건조, 폐색감, 열감, 소양감, 자주 搔爬하여 출혈, 臭水, 腥臭 등 특이한 냄새

- 분류

1) 진성 취비증: 가피 형성, 악취 극심

2) 단순 취비증: 부비동염으로 발생, 가피 형성

3) 후두 취비증: 점막과 뼈의 위축, 목에 가피 발생

4) 기관 취비증: 점막과 뼈의 위축, 가피가 기관까지 파급

- 변증론치

1) 肺經燥熱: 鼻腔 乾燥感, 灼熱感, 疼痛이 심함 + 咽痛 = 清燥救肺湯, 養陰清肺湯

2) 肺腎陰虛: 寒冷시 두통 + 인두 乾燥感, 미약한 통증 = 百合固金湯, 地栢地黃湯

3) 肺脾氣虛: 少氣, 便糖 등 동반 = 補中益氣湯

4) 외치: 魚腥草, 白芷 各 30g을 滴鼻

- 치료: 대증요법, 따뜻한 생리식염수로 비강내 세척, 취침전 glycerin 면구 삽입

鼻梅毒 비매독

- 선천매독: 初生兒 鼻梅毒. 피부발진 선행하여 비점막에 발생. 대부분 2주일 이내 발생

- 후천매독: 초기(손가락, 의료기구에 의한 無辜梅毒. 감염 3일 후에 발생), 2기 매독(감염 후 6~9주에서부터 약 2~3년 계속. 전신 매독진, 비점막 점막반 동반), 3기 매독(초기, 2기보다 많음. 약 10%에서 本證 초래)

- 증상: 초기 鼻塞, 비점막 粘膜斑 발생. 점차 鼻塞 증가, 前頭痛 발생. 潰瘍, 惡臭, 분비물, 痂皮 형성. 결국 膿性 血性 分泌物 있는 후 鼻中隔 穿孔, 外鼻 畸形 초래

- 치료

1) 초기: 加減通聖散, 化毒散, 仙遺糧湯

2) 만성: 通聖五寶丹, 換骨散, 回生保命丹

3) 鼻崩壞, 膿血 淋漓할 때: 活魂丹

4) 通治方: 三黃敗毒散

04 부비동질환

부비동염

- 韓: 腦漏, 腦砂, 腦滲, 控腦痧, 控腦砂, 歷腦, 腦瀉, 腦絲, 腦滲爲涕

- 원인

1) 實證: 급성 鼻淵. 肺經風熱, 肝膽濕熱, 脾胃濕熱

2) 虛證: 만성 鼻淵. 肺氣虛弱, 肺燥, 脾胃虛弱, 腎陰虧損

- 증상 : 주증상(鼻流腥臭, 鼻塞, 嗅覺減退). 一側 혹은 兩側으로 濁涕가 흐르고 痰이 많으며, 鼻塞하면 비린 냄새, 심하면 眩暈, 頭重, 頭痛, 健忘症 등과 함께 嗅覺 減退

→ 주증상은 누런 코가 나오면서 코가 막히고 냄새를 잘 못맡게 됨

1) 急性: 黃濁, 膿血이 섞인 鼻涕不止, 비색, 후각 감퇴, 穢腥臭, 전액두통 甚 + 風熱表證이나 脾胃 및 肝膽濕熱의 증상과 兼

2) 慢性: 微黃, 白色의 濁하고 血絲 섞인 점조한 鼻涕, 비색 甚, 불문향취, 頭暈, 頭重痛 + 氣虛 또는 陰虛火旺한 증상과 兼

- 변증론치

1) 實證: 肺經熱盛(銀翹散合 蒼耳子散, 荊芥蓮翹湯, 荊防敗毒散), 肝膽火熱(龍膽瀉肝合蒼耳子散, 黃連通聖散), 脾胃濕熱(甘露消毒飲, 黃芩滑石湯, 升麻石膏湯)

2) 虛證: 脾虛肺弱(補中益氣湯, 十全大補湯), 腎陽虧虛(腎氣丸加減, 八味地黃湯), 腎陰不足(左歸飲加減, 六味地黃湯, 雙和湯, 清上補下丸)

3) 通治: 古拜散

4) 咳吐膿血할 때: 桔梗湯, 人蔘平肺散

5) 外治: 蒼耳子散 粉末 - 吹鼻法

가. 급성 부비동염

- 호발부위: 상악동과 사골동의 동시 침범. 단독시 상악동 > 사골동 > 전두동 > 접형동 호발

- 주로 어른에게서 잘 오며 5세 미만의 어린이는 생기지 않음

- 부비동이 만들어지는 시기가 5세 이후라서

- 원인: 급성 비염의 점막 감염이 부비동에 파급, 또는 점막 부종, 기형, 증식 등으로 자연

개구부가 폐쇄되어 발생. 이 외 외상, 충치, 발치, 잠수, 비행 등

- 기전: 부비동 자연개구부의 폐쇄와 점액섬모기능 저하 → 부비동내 저산소증, 점액 저류 → 세균 감염

- 증상: 두통(오전 심), 37°C ~ 37.5°C의 미열, 초기 장액성 분비물에서 점차 점액농성으로 변화, 호흡성 후각장애

- 진단: 동통 및 점액농성 비루, 비강소견, X선 검사

- 치료: 항생제, 국소 점막 수축제, 혈관수축제

각 부비동염의 특징

→ 통증위치 알아두기

★ 상악동염, 사골동염, 접형동염의 동통과 방산통의 특징을 서술. (13)

1) **급성 상악동염**: 협부 동통과 상악치열 치통. 비경상 급성 비염소견이 심하고 중비도에 점액성 혹은 농성 분비물 보임

2) **급성 사골동염**: 비근부 및 안와부 내측 심부통증(Gruenwald's point). 처음 두통부위가 일정하지 않다가 점차 비근부로 모임

3) **급성 전두동염**: 전두부 국한통, 안와연 내측 신경공 부위의 심한 통증(Ewing's point), 눈썹 내측 압통, 안통, 유루 동반

4) **급성 접형동염**: 범부비동염 형태로 후사골동염에서 병발. 안와 내후측과 후두 및 두정부 통증. 후비경검사상 비인강에 고름 보임

급성 부비동염의 감별표

→ 부비동염에서는 중비도를 꼭 확인해야함

	긴장감 압박감	통증	압통	방산통 부위	부종	비강내 부종, 발적 부위	농성 분비물 위치
급성 상악동염	볼, 이마	볼	볼	이마	볼	하비갑개 상연	중비도, 하비갑개 상연
급성 전두동염	이마	이마	이마		이마, 눈썹	중비갑개 외측연	중비갑개 전상 단부
급성 전사골동 염	비근부, 이마	비근 부, 이마	비근	안와부	비근	중비갑개	중비도
급성 후사골동 염	두정부	두정부		측두부		후각부, 상비도	후각부, 상비도
급성 접합동염	두정부, 측두부	두정 부, 측두부		측두부		후각부, 상비도	상비도

나. 만성 부비동염

★ 15세 남아. 3개월 전부터 비폐색, 누런 콧물, 후비루 등을 호소하며 내원. ~ 우측은 빛이 차단되어 검게 보였다. 의심되는 질환의 부위 및 서의학적 질환은? (08,10,12,18)

- 부비동내의 반복된 감염 혹은 지속된 감염에 의해 부비동 점막의 비가역적 병변이 초래된 만성 염증 상태

- 상악동염과 사골동염이 다발

- 증상: 비폐색(하비갑개의 비후 및 종창, 농성 비루의 비강내 저류, 비용), 비루(점액 혹은 점액농성), 후비루, 기침, 비인강 건조감, 인두 이물감(콩콩거림), 이내 충만감, 후각장애, 비출혈, 두통, 비성 주의산란증

→ 콧물 흘림이 많아서 생기는 후비루는 무시. 앞으로 나오는건 없는데 뒤로 넘어가는 후비루가 많으면 만성비염, 만성 부비동염 의심 가능

- 진단: 비경 및 내시경, X선 검사

- 치료: 부비동 세척, 수술요법(보존적, 근치수술), 내시경 수술

- 합병증

1) 안와내 합병증: 전두동, 사골동 병변. 결막부종, 안구돌출, 안근마비, 시력저하 등

2) 두개내 합병증: 뇌막염, 경막외 농양, 경막하농양, 뇌종양

cf) 소아 부비동염: 상대적 넓은 자연개구부로 급성 부비동염의 증상보다 경미하여 반복되는 후비루와 지속적 기침만 보임

cf) 치성 상악동염: 편측성 부비동염의 일종. 대구치 치근의 염증이 상악동 점막에 파급되어 발생. 특징적인 악취성 농성비루

→ 비강 이물, 종양, 치성 상악동염, 진균성 질환 : 편측성(일측성)이 나타날 때 떠올려야 하는 질환들 잘 알아두기

부비동종양

★ 비공에서 성취, 오메하고 황탁한 탁체 끊이지 않고 반복적 비혈, 비색, 극심한 비통이 있으면서 두통, 안통, 상악통 등을 동반증상으로 나타났다. 이에 해당하는 동의학적 병명은? (08,13,15,19)

가. 양성종양

- 종류: 골종, 유두종, 섬유이형성증, 모세혈관성 혈관종 등

- 골종: 전두동. 점차 토안, 구개종창, 삼차신경통 발생, 두개내 감염 유발

- 유두종: 비강 측벽에 호발. 도립유두종(손가락 모양, 비강측벽에 호발), 폴립상 유두종(배추꽃 모양, 비중격에 발생)

- 모세혈관성 혈관종: 사춘기 이후 비중격에 발생. 비출혈 유발

- 점액종: 전두동. 자연개구부

- 섬유이형성증: 상악골, 하악골에 다발. 10~20대에서 활발하게 진행. 점차 안면종창으로 인한 기형, 두통, 비만증, 정신적 불안 유발

나. 악성종양

- 종류: 癌腫, 肉腫, 黑色上皮腫. 주로 편평상피암. 상악동 호발

- 증상: 초기에 비폐색, 동통, 화농성 비루 순으로 발생. 점차 진행되면 동통, 비폐색 및 암자색 출혈, 악취, 협부종창 발생

- 상악암: 40세 이상에서 비용, 부비동염, 비출혈과 완고한 두통, 치통이 있으면 의심

- 韓: 鼻菌
- 원인: 膽經熱盛, 風熱, 痰熱
- 치료: 癰疽, 疔瘡의 內, 外治法 활용. 托裏消毒飲, 五味消毒飲, 仙方活命飲, 十六味流氣飲

05 증후성 비질환

총론에서 했던 내용들 겹쳐서 간단히 보고 넘어감

鼻痛 비통

- 원인: 風熱이나 風邪侵犯, 痰火上衝, 濕熱瘀滯
- 증상: 鼻竅 내부에 은은하거나 때로 극심한 동통 발생
- 치료
 - 1) 風邪侵犯: 人蔘順氣散, 銀翹散, 通氣驅風湯
 - 2) 痰火上衝: 二陳湯
 - 3) 濕熱瘀滯: 防風通聖散, 調胃承氣湯

【서양의학】 비강내의 동통

- 1) 外鼻의 동통
 - 외비의 손상, 鼻癰, 비매독 및 결핵, 진행성 괴저성 비염, 비낭창, 건성 전비염, 비중격 혈종 및 농양 등
- 2) 비강내의 동통
 - 만성 비후성 비염, 위축성 비염, 부비동염, 비강 및 부비동의 종양, 비강 건조가 심하거나 鼻茸이 커져 있을 때

鼻焦乾 비초건

- 이명: 鼻乾, 鼻燥, 鼻乾枯, 鼻焦乾
- 원인: 肺經燥熱, 肺腎陰虛, 脾肺氣虛
- 증상: 비규내 건조, 작열감, 비색 / 두통, 두훈, 홍만, 皮毛乾枯 등
- 치료: 傷寒表證(麻黃湯, 葛根湯), 肺經燥熱(清燥救肺湯, 養陰清肺湯), 肺腎陰虛(百合固金湯 加減, 六味地黃湯), 脾肺氣虛(十全大補湯, 四君子湯加減, 補中益氣湯)

【서양의학】

코질환(단순성 위축성 비염)과 전신적인 질환으로 비점막이 **건조**되어 있는 증후

단순성 위축성 비염

- 원인: 불명. 생활, 직업조건과 유관
- 증상: 자각증상은 현저하지 않음. 두중감, 비강 및 비인강 건조감, 후각저하
- 비경상 비강이 넓고 후비공까지 보임. 위축은 주로 하비갑개에 국한되고 코안은 건조하며 딱지가 군데군데 붙어있음
- 치료: 생리식염수나 2% 탄산수소나트륨으로 세척.

鼻內瘙癢 비내소양

- 주로 噴嚏와 병발. 火症, 風寒感冒
- 鼻痒, 咽痛, 脈浮: 風熱邪
- 鼻痒, 鼻乾: 肺經燥熱
- 鼻痒, 噴嚏, 鼻流清涕 同時 발생: 肺衛不固로 外感風寒
- 小兒 鼻疳(鼻蠱瘡): 鼻痒, 鼻竅兩傍 瘙痒, 糜爛潮紅하고 瘡이 口脣에 파급. 반복 발생, 久不愈: 乳食不調, 濕熱薰蒸, 肺經風熱
- 치료 : 防風通聖散 加 白附子, 白殭蠶 등

→ 코가 간지러운거는 알레르기 비염에 준해서 보면 됨

鼻痠 비산

- 鼻竅內的 저린감, 즉 痠感 혹은 辛酸感
- 원인: 風熱, 痰火
- 증상: 鼻根이나 鼻孔內에 痠脹感 또는 痠痛 / 鼻塞, 황색 혹은 청백색 鼻涕
- 치료: 涼隔散, 銀翹散, 二陳湯加減. 鼻痛에 준하여 치료

【서양의학】 비강내의 이상감각 및 鼻部의 동통

- 鼻部의 동통, 또는 鼻性 신경증의 일부 증상
- 원인: 비중격 신경증, 안면신경통, 국소적 비강내 질환(만성 비후성 비염, 위축성 비염, 알레르기 비염, 만성 부비동염, 鼻茸이 커져 있거나 비강의 소양, 건조감이 심할 때)에 발생

鼻砭痧 비침사

- 원인: 肺內熱한데 風邪침범으로 鬱結되어 발생
- 증상: 痧 발생 + 左鼻 혹은 右鼻, 혹은 兩鼻가 모두 폐색
- 치료

1) 外治: 燈心草로 鼻 자극하여 噴嚏 유도

2) 鍼灸治療: 水溝, 迎香, 厲兌, 前谷 등 刺針

→ 전염병 등에서 콧속에 반진이 만들어지는 양상

鼻出臭氣 비출취기

- 이명: 臭鼻症
- 원인: 風寒이나 火熱의 病邪가 肺에 오랫동안 鬱滯되었다가 鼻를 熏蒸
- 주증상: 비강내 臭氣, 때때로 濁涕, 하비갑개 점막과 골의 위축, 농성 鼻漏, 痂皮
- 치료: 痂皮나 鼻漏를 감소시킴.

鼻冷 비냉

- 원인: 臟腑 寒冷하고 陽氣 부족하여 발생
- 증상: 안면이 黃, 白色을 띠고 鼻部 전체 혹은 鼻孔, 鼻尖에 寒冷感이 있고 滑利. 鼻部가 青色을 띠면 복부 疼痛하고 寒冷하다.
- 1) 溫中하는 약물 투여
- 2) 人蔘, 附子, 黃芪 등 약물 투여
- 3) 大病後 鼻部가 갑자기 寒冷하면 不治症
- 4) 大病後 鼻靑, 面靑, 腹痛, 寒冷感이 있으면 陽氣 회복 어려움

鼻如烟煤 비여연매

- 원인: 臟腑에 陽毒 病邪가 왕성하여 발생
- 증상 및 치료: 鼻部가 烟煤와 같음
- 清熱 약물 투여

肺風粉刺 폐풍분자

- 이명: 酒刺, 面疱, 粉刺, 酒齣鼻
- 원인: 肺經血熱로 발생
- 증상: 面鼻部에 面疱와 같은 발진, 인설 발생, 紅赤腫痛. 壞破되면 白粉汁 배출. 오래되면 白屑 형성
- 치료
- 1) 枇杷清肺飲
- 2) 外用: 顛倒散

嗅覺障礙 후각장애

→ 질환 자체는 많지 않은데, 임상에서 감별할게 좀 중요해서 잘 봐두면 좋은 파트

- 韓: 失臭, 鼻聾, 不聞香臭
- 원인: 肺經風熱, 脾胃濕熱, 肺脾兩虛, 血瘀阻肺
- 증상: 후각이 점차 감소 또는 소실되어 不聞香臭 / 鼻塞, 황색 혹은 청백색 鼻涕
- 치료
- 1) 심인성: 歸脾湯, 天王補心丹
- 2) 히스테리: 半夏厚朴湯
- 3) 鼻塞不聞香臭: 麗澤通氣湯, 溫衛湯, 溫肺湯
- 4) 부비동염, 비염: 防風通聖散, 荊防地黃湯, 荊防敗毒散 加味
- 5) 錯嗅나 幻嗅: 증상에 따라 몸의 기능을 강화한다. 十全大補湯, 歸脾湯, 六味地黃湯, 人蔘養榮湯

【서양의학】 후각기능장애(후각 소실, 감퇴)

- 분류: 호흡성, 진성, 중추성 후각탈출
- 원인: 감각신경성(지각성), 전도성, 혼합성, 중추성, 내분비성(당뇨, 갑상선기능저하증), 대사성(Vit A, B12, 간경화, 신부전), 약물 및 중독성, 정신신경질환(정신분열증, 우울증)
- 치료: 아연제제, 비타민 A